Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Naviraí
1.ª Vara Cível

SENTENÇA

Vistos e examinados estes autos sob nº 0802076-61.2023.8.12.0029 de **AÇÃO Procedimento Comum Cível** em que é **Autor:** Maria Aparecida Lopes e **Réu:** Município de Naviraí e outro

Maria Aparecida Lopes, qualificada nos autos, assistida por sua curadora *Rubhia Carla Lopes da Silva Albrecht*, move a presente **Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência** em desfavor do **Município de Naviraí** e do **Estado de Mato Grosso do Sul,** também qualificados, dizendo, em resumo, que possui 67 anos de idade e é portadora de sequelas de traumatismo encefálico grave, necessitado, com urgência, fazer uso dos medicamentos **fenitoína, sertralina, amitriptilina, prysma** e **baclofeno**. Afirma que não tem condições financeiras de arcar com o custo respectivo e também não conseguiu obter, administrativamente, tais medicações dos requeridos, não lhe restando outra saída senão o ajuizamento da presente ação. Com base em tais fatos sucintos, objetiva a condenação dos Requeridos para que lhe forneçam os medicamentos supracitados, pelo tempo de que a requerente necessite para seu tratamento. Apresentou outros requerimentos. Instruiu a inicial com os documentos de fls. 13/25.

Instada (fls. 28), a parte Autora apresentou novos documentos necessários à emissão do parecer técnico (fls. 30/31, 34 e 43).

Parecer do Núcleo de Apoio Técnico às fls. 46/56.

Tutela de urgência deferida (fls. 57/60).

Citados, os Requeridos ofereceram contestação às fls. 71/79 e 81/85.

O Requerido Estado de Mato Grosso do Sul na contestação ofertada, em síntese, discorreu pela necessidade de observância ao Tema n. 1.234 e do Tema n. 06 do STF, em relação aos requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. Na eventualidade, pede o direcionamento da obrigação ao Município de Naviraí.

O Requerido Município de Naviraí, em sua defesa, alegou, em suma, que os medicamentos cloridrato de sertralina, eszopiclona e baclofeno não estão padronizados, de modo que deve ser respeitado o parecer do Núcleo de Apoio Técnico. Pugnou pela improcedência do pedido.

A parte autora apresentou impugnação à contestação, oportunidade em que postulou pelo julgamento antecipado do feito (fls. 91/92).

O Requerido Estado de Mato Grosso do Sul apresentou acordo administrativo firmado com o Município para o cumprimento da tutela provisória (fls. 93).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 26/06/2025 às 13:48 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802076-61.2023.8.12.0029 e código kN598tj5.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Naviraí
1.ª Vara Cível

Na fase de especificação de provas, os Requeridos disseram não possuir provas para produção (fls. 101 e 102/103).

Manifestação pelo Estado de Mato Grosso do Sul informando a disponibilização do medicamento Baclofeno (fls. 104) e a efetivação de depósito para a aquisição de Sertralina e Eszopiclona (fls. 106).

Às fls. 108/133 foi juntado ofício referente ao Agravo de Instrumento n. 1400257-59.2025.8.12.0000.

É o relatório no essencial.

Decido.

Conheço diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I, do Novo Código de Processo Civil, pois desnecessária a produção de outras provas, o que, aliás, não foi requerido por nenhuma das partes.

O ordenamento jurídico brasileiro tutela o direito à saúde, determinando o artigo 196 da Constituição Federal que:

> "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Por sua vez, a Lei n.º 8.080, de 19/9/90, que trata das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, estatui em seu artigo 2.º quec *"A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício"*. E, no artigo 7.º, que:

> "As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde − SUS, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:
> I − universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; II − integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; IX − descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo: a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;".

Basta o dispositivo previsto no texto constitucional citado para se chegar à conclusão de que se deve garantir o direito de todos, <u>independentemente da condição financeira,</u> à saúde. As normas infraconstitucionais, que procuram dar efeito integrador ao texto constitucional, seriam até desnecessárias se existisse a consciência, por parte de todos os responsáveis pelas administrações dos entes federados, de que a Constituição Federal não é puramente analítica. A Constituição, com sua força normativa,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 26/06/2025 às 13:48 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802076-61.2023.8.12.0029 e código kN598tj5.

constitui energia que deve influir na realidade. O dever da Administração de adquirir o necessário ao atendimento de pessoas doentes, imposto pela Constituição, não pode ser inviabilizado por entraves burocráticos e questiúnculas referentes à competência deste ou daquele órgão para distribuição. A distribuição de competências entre os entes federados é firmada para melhor servir aos cidadãos e não para aumentar seus sofrimentos e angústias, motivo pelo qual há solidariedade entre eles.

A edição da Lei nº 12.401/2011, em que pese sua importância e necessidade de respeito, não pode implicar em preterimento dos direitos do cidadão. A lei deve respeito à Constituição Federal e o Poder Judiciário é o garante das promessas do constituinte. Assim, como a Carta Magna traz a promessa de ampla proteção no campo da saúde, não pode o ente público se esquivar da sua obrigação, até porque estamos diante de tema que perpassa pela dignidade da pessoa humana. O Tribunal de Justiça do Estado, a respeito do tema já decidiu:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 12.401/2011 – PREVISÃO CONSTITUCIONAL QUE PREVALECE SOBRE LEI, PORTARIA OU ATO NORMATIVO INFERIOR – DIREITO À SAÚDE – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR – PERIGO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – MEDICAMENTO EXPERIMENTAL – SEM RELEVÂNCIA DESDE QUE INDICADO POR MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE – RECURSO IMPROVIDO. Não há que se falar no reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei n. 12.401/2011, posto que já é pacífico o entendimento de que a garantia ao acesso igualitário das pessoas saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal está acima de qualquer lei, portaria ou ato normativo inferior. Uma vez sopesados os interesses de ambas as partes, verifica-se que o princípio da integralidade que é fundamento do interesse do recorrente, não deve prevalecer sobre o princípio basilar da pretensão do recorrido, que é o da dignidade da pessoa humana. Diante da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, como a prova inequívoca do direito e a verossimilhança das alegações acerca da necessidade do medicamento pleiteado, a decisão a quo deve ser mantida. Já é sedimentado o entendimento de que, se beneficiar o paciente, o médico pode utilizar um medicamento para finalidades diversas das indicadas, mesmo que em fase experimental. (TJMS, Quarta Câmara Cível, relator Desembargador Claudionor Miguel Abss Duarte, agravo nº 2012.015841-8, julgado em 17.07.2012).*

Desse modo, é patente a responsabilidade dos réus quanto ao atendimento das demandas relacionadas à saúde, o que, de resto, ficou assentado pelo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 793, que estabeleceu a seguinte tese:

> Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, **compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento** conforme as regras de repartição de competências **e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro**. (Grifei)

Portanto, os requeridos não podem se esquivar do cumprimento da obrigação, embora caiba ao juiz estabelecer, caso a caso, qual ente federativo deverá cumpri-la com prioridade.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 26/06/2025 às 13:48 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802076-61.2023.8.12.0029 e código kN598tj5.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Naviraí
1.ª Vara Cível

Demonstrada a responsabilidade dos requeridos, verifico que, no caso, a parte autora demonstrou que possui uma demanda na área da saúde e que não conseguiu dos requeridos, administrativamente, os medicamentos de que necessita.

Pois bem, com relação aos medicamentos Fenitoína e Cloridrato de Amitriptilina não se verifica maiores problemas de compelir os Requeridos a fornecê-los, uma vez que, de acordo com parecer do NAT, estão padronizados na RENAME 2022, sob o Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) de responsabilidade dos Municípios (fls. 52, item VII) e, portanto, havendo prescrição médica para seu uso, como é o caso dos autos, os demandados não podem fugir da sua obrigação constitucional.

Porém, a mesma conclusão não se aplica aos fármacos Cloridrato de Sertralina, Eszopiclona, Baclofeno, pois eles não estão padronizados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2022) ou outro ato normativo do SUS.

Importa destacar, outrossim, que para os medicamentos pleiteados, os quais não estão padronizados pelo SUS, devem ser atendidas as exigências estabelecidas nos temas 106/STJ e 1234/STF para que seja determinada a concessão deles, justamente por se tratar de medicamentos não incorporados.

Registro que, ante à necessidade de resguardar os direitos fundamentais envolvidos, o caso em exame será apreciado sob a ótica do Tema 106/STJ, tendo em vista que a presente ação foi ajuizada em julho de 2023, ou seja, antes do julgamento do Recurso Extraordinário nº 566.471/RN (Tema 06/STF), em 20/06/2024, o qual sintetizou a súmula vinculante 61, com a seguinte redação: *"A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)"*.

Neste passo, em razão da tese fixada pelo STJ no julgamento do Resp 1.657.156 (tema 106), deverá ser demonstrado o preenchimento dos seguintes requisitos para o fornecimento dos medicamentos Cloridrato de Sertralina, Eszopiclona, Baclofeno pelo ente público:

> *a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;*
> *b) incapacidade financeira do autor de arcar com o custo do medicamento prescrito;*
> *c) existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanatária – ANVISA.*

Os dois últimos requisitos exigidos pelo REsp em comento são de fácil constatação, pois denota-se que os remédios pretendidos possuem registro na ANVISA (fls. 51, item IV) e que a Requerente trata-se de pessoa hipossuficiente, já que se

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 26/06/2025 às 13:48 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802076-61.2023.8.12.0029 e código kN598tj5.

encontra assistido pela Defensoria Pública local, e afirma tal condição às fls. 12.

Com relação ao primeiro requisito *(comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS*), está devidamente demonstrado nos autos por meio do laudo médico de fls. 44/45, cabendo destacar os seguintes trechos do referido documento médico que levam a tal conclusão:

> Trata-se de uma paciente acamada, que vive em estado vegetativo como sequela de acidente de trânsito ocorrido há vários anos.
> A paciente atualmente se encontra em internação domiciliar em quarto equipado como leito de unidade semi-intensiva. Alimenta-se através de sonda nasoentérica através de alimentação especial e específica, em uso de sonda vesical e uso de fralda. A paciente não tem resposta á estímulos motores e verbais (ressaltando o estado vegetativo não comicial).
> Há muito tempo a paciente faz uso das seguintes medicações:
> 1) Prysma 2 mg - 01 comprimido á noite
> 2) Cloridrato de Amitriptilina 25 mg - 01 comprimido pela manhã e 02 comprimidos á noite
> 3) Baclofeno 10 mg - 01 comprimido á noite
> 4) Fenobarbital 100 mg - 1 comprimido e meio (150 mg) á noite
> 5) Fenitoína sódica 100 mg - 01 comprimido a cada 12 horas
> 6) Cloridrato de sertralina 50 mg - 01 comprimido á cada 12 horas
>
> As medicações descritas acima são de uso contínuo e de período indeterminado, podendo até mesmo serem utilizadas até o fim da vida biológica da paciente.
> Ressalto que em casos como o da paciente, é de grande dificuldade conseguir chegar num limiar de controle e equilíbrio medicamentoso (conseguir adaptar o organismo com as combinações de medicamentos e obter os efeitos desejados com a terapêutica).
> Os medicamentos descritos são de diversas classes: calmante, antidepressivo, indutor do sono, antidepressivo e anticonvulsionante.
> Por mais que o quadro da paciente seja comicial, ainda há atividade cerebral e do sistema nervoso autônomo simpático e parassimpático, e tais medicações
>
> ajudam a equilibrar a desordem de impulsos elétricos emitidos pelo cérebro, que já não consegue manter uma ordem eficaz de funcionamento como de uma pessoa em saúde plena, como controle normal do sono, movimentos dos nervos e músculos e órgãos, como intestino, bexiga urinária, entre outros.
> A suspensão de algum destes medicamentos, bem como qualquer substituição, pode acarretar em desequilibro completo de uma terapêutica que há muito tempo foi acertada e se mantém estável.
> Sendo assim, conslui-se que a paciente é totalmente dependente da terapêuticas já mencionada e qualquer mudança, substituição ou ausência de algum dos medicamentos pode ocasionar um efeito em cascata de dificil controle e presunção.

Em relação ao preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo julgamento do RE 1.366.243/SC (Tema 1.234/STF) a respeito do fornecimento dos medicamentos não incorporados às políticas públicas, inicialmente, destaco abaixo as teses firmadas pela referida decisão:

> *IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 26/06/2025 às 13:48 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802076-61.2023.8.12.0029 e código kN598tj5.

4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), ***o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.***

4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.

4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

4.3) ***Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS****.*

4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, ***não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.*** – destaquei

Desse modo, tornou-se imprescindível o exame judicial do ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec, bem como a negativa de fornecimento na via administrativa. Ainda, conforme exposto acima, é do autor o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco pleiteado.

No caso, a autora relatou ter buscado administrativamente os fármacos junto aos entes públicos, todavia, foi informada pelo Município de Naviraí que *"[...] os medicamentos Sertralina 25mg, Prysma 2mg e Baclofeno 10mg, não são padronizados no SUS, portanto, não estão disponíveis na farmácia municipal"* (fls. 20).

Em relação ao exame dos atos normativos da Conitec, não há informações acerca da avaliação dos medicamentos Cloridrato de Sertralina e Eszopiclona, restando prejudicada a análise em relação a eles. Já o Baclofeno foi avaliado pela Conitec no Relatório de Recomendação n. 715, sendo recomendada a não incorporação para o tratamento de pacientes adultos com espasticidade (fls. 53, item VII).

Quanto à comprovação, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, da segurança e eficácia dos fármacos, bem como da inexistência de substituto

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 26/06/2025 às 13:48 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802076-61.2023.8.12.0029 e código kN598tj5.

terapêutico incorporado pelo SUS, entendo que os elementos constantes nos autos são suficientes para comprovar a imprescindibilidade da medicação pleiteada.

Apesar da parte autora não ter se desincumbido de demostrar, cientificamente, por meio de ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise, a eficácia dos fármacos, verifico que o Parecer do NAT trouxe informações e evidências científicas sobre os cinco medicamentos que atestam seus resultados satisfatórios (vide item III, fls. 47/51).

Além disso, é preciso considerar que o presente caso se trata de situação excepcional, que restou devidamente demonstrada com o laudo médico de fls. 44/45, já mencionado anteriormente. Isso porque, além de se tratar de paciente idosa, com sequela de traumatismo craniano, verifica-se que ela se encontra acamada em estado vegetativo, com sério risco de agravamento de seu quadro clínico, caso não mantida a medicação receitada pelo médico que a acompanha.

Neste passo, reitero, *in tontum*, a decisão que deferiu a tutela provisória (fls. 57/60), cujos fundamentos mantiveram inalterados durante o transcorrer processual e que, inclusive, foram mantidos pelo Tribunal, consoante fls. 108/133:

> "De mais a mais, os documentos acostados comprovam a necessidade dos fármacos receitados (f. 44-45).
> O laudo médico de f. 44-45 é minucioso ao descrever o estado de saúde delicado da requerente, que se encontra em coma vígil, em leito domiciliar semi-intensivo.
> O médico que a acompanha descreveu que o esquema medicamentoso não pode ser modificado em razão do quadro excepcional da paciente, que não responde a nenhum estímulo (f. 44-45):
> [...]
> A situação da autora não é equiparável aos usuários do SUS em geral.
> Trata-se de paciente idosa em estado de coma e que dependente de um esquema medicamentoso que deu certo e não pode ser modificado.
> Desse modo, está suficientemente comprovada a necessidade dos fármacos neste caso, ainda que não padronizados."

Por estas razões, o fornecimento dos medicamentos deve ser garantido, uma vez demonstrada a imprescindibilidade deles, mesmo diante de parecer desfavorável da Conitec quanto ao *baclofeno*, sendo a procedência do pedido a medida que se impõe.

Ante o exposto, confirmando neste momento a antecipação dos efeitos da tutela, **JULGO PROCEDENTE** o pedido que **Maria Aparecida Lopes** fez em desfavor do **Município de Naviraí** e do **Estado de Mato Grosso do Sul**, qualificados, para o fim de determinar aos réus que forneçam por meio de seus órgãos executores competentes, à parte autora os medicamentos **Fenitoína, Sertralina, Amitriptilina, Prysma e Baclofeno**, pelos nomes comerciais ou princípios ativos, nas dosagens prescritas pelo médico e durante o período em que forem necessários para o tratamento da autora, sob pena de sequestro de verba

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 26/06/2025 às 13:48 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802076-61.2023.8.12.0029 e código kN598tj5.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Naviraí
1.ª Vara Cível

pública necessária ao cumprimento da obrigação.

Em atenção ao Tema 793 do STF, direciono ao Município de Naviraí o cumprimento da obrigação relativamente à Fenitoína e Amitriptilina, pois compõem a lista farmacêutica básica de competência dos municípios, conforme demonstrou o parecer do NAT (fls. 53). Quanto ao Cloridrato de Sertralina, Eszopiclona e Baclofeno, uma vez que o NAT informou que não é possível indicar o ente público responsável, deixo de dar aplicação tema 793/STF para manter a responsabilidade solidária entre os demandados. De qualquer forma, resta mantida a solidariedade entre os requeridos quanto ao cumprimento integral da obrigação.

Sem custas, *ex vi legis*.

Em vista do que restou decidido no Tema n. 1.002 do STF[1], condeno os Requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, que fixo em R$800,00 (oitocentos reais), com fulcro no art. 85, §8º do CPC. Ainda, com fulcro no art. 87, §1º, do CPC, determino a distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais em 50% entre os litisconsortes passivos, ou seja, cada Requerido deverá arcar com a metade dos honorários fixados.

Declaro **extinto** o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Considerando que o Requerido Estado de Mato Grosso do Sul efetuou o depósito da quantia de R$2.417,19 para a aquisição de medicamento (fls. 106), **junte aos autos o extrato da conta judicial** e, após, abra-se vista dos autos à Defensoria Pública para, em 5 dias, requerer aquilo que entender de direito, observando que, no caso de haver interesse no levantamento da quantia, deverá apresentar três orçamentos e postular pelo levantamento daquele que apresentar o menor preço, sob pena de devolução da quantia aos cofres públicos.

Sentença sujeita a reexame, pois não é certo o valor da condenação, nos termos do art. 496, § 3º, do CPC e Súmula 490 do STJ.

Assim, decorrido o prazo recursal, mesmo sem oposição de recurso pelas partes, remetam-se os autos ao E. TJMS para reexame.

Havendo o trânsito em julgado, arquive-se com as formalidades.

P.R.I.C.

Naviraí/MS, datado e assinado digitalmente.

[1] O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002, fixou tese vinculante no sentido de que "é devido o pagamento de *honorários* sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra."

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 26/06/2025 às 13:48 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802076-61.2023.8.12.0029 e código kN598tj5.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Naviraí
1.ª Vara Cível

Eduardo Magrinelli Júnior
Juiz de Direito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 26/06/2025 às 13:48 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802076-61.2023.8.12.0029 e código kN598tj5.